# ヒアリングシート（No.1）

**1**. 属性情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| フリガナ | ノムラ　シンスケ | 性別 | 男 |
| 申込人名 | 野村　信介 | 電話番号 | 090-6171-1535 |
| 生年月日 | 1983年（昭和58年）3月25日 | 出身大学 | 防衛医科大学校　医学部（2008年卒） |
| 現住所 | 〒889-2151　宮崎県宮崎市熊野7465 | | |
| 出身地 | 千葉県市川市 | | |

**2**. ご家族構成

| フリガナ・ご家族名 | 生年月日／性別 | 続柄 | 同居 | 勤務先・在学校 |
|---|---|---|---|---|
| ノムラ　シホ<br>野村　志保 | 1985年（昭和60年）9月19日 | 配偶者 | 同居 | グループホーム勤務（看護師） |
| ノムラ　ケンゴ<br>野村　健悟 | 2009年（平成21年）12月30日 | 子 | 同居 | 宮崎県立宮崎商業高校 |
| ノムラ　ハルト<br>野村　悠人 | 2011年（平成23年）7月4日 | 子 | 同居 | 宮崎市立木花中学校 |
| ノムラ　メイ<br>野村　芽生 | 2013年（平成25年）9月8日 | 子 | 同居 | 宮崎市立木花中学校 |
| ノムラ　ユズハ<br>野村　柚羽 | 2016年（平成28年）2月15日 | 子 | 同居 | 宮崎市立学園木花台小学校 |

**3**. 申込人職務経歴・業歴

| 期間 | 勤務先・職位 |
|---|---|
| 2008年～<br>2010年 | 防衛医科大学校病院　研修医 |
| 2010年～<br>2011年 | 防衛医科大学校 外科学講座　専攻医 |
| 2011年～<br>2013年 | 国立病院機構 災害医療センター 救命救急科　医員（出向）／東日本大震災（福島）災害派遣（患者後送） |
| 2013年 | 国家公務員共済組合 虎ノ門病院　外科研修 |
| 2018年～<br>2019年 | マサチューセッツ総合病院（ハーバード大学・米国）　研究員 |
| 2020年～<br>2021年 | 防衛省 陸上幕僚監部 衛生部 |
| 2021年 | 自衛隊大規模接種センター　計画・運営・派遣 |

| 期間 | 勤務先・職位 |
| --- | --- |
| 2021年～<br>2022年 | 陸上自衛隊熊本病院　外科部長 兼 健康管理センター長 |
| 2022年～<br>2023年 | 宮崎大学医学部 消化管・内分泌・小児外科学　助教 |
| 2023年 | 宮崎県立日南病院　外科医長 |
| 2023年～現在 | 医療法人社団明景会 早水公園クリニック　副院長（現職） |

現勤務先での勤務状況

| 勤務地名 | 医療法人社団明景会 早水公園クリニック（宮崎市） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1日平均診察人数 | 通常 約150人／日<br>冬季ピーク 約250人／日 | 専門科目 | 外科・消化器外科 |
| 年間手術件数<br>（手術実施の場合） | 外科小手術・内視鏡 含め年間 30 件<br>手術は医療法人仁愛会横山病院にて実施 | 外来最多の疾患例 | 生活習慣病（高血圧・脂質異常症・糖尿病）、高尿酸血症<br>痛風、尿管結石、感染症（成人/小児含む感冒・インフルエンザ/COVID-19、胃腸炎、膀胱炎）、甲状腺疾患、急性腹症含む消化器疾患、外傷処置、気管支喘息、花粉症、睡眠時無呼吸症候群、認知症 |

# お客さまヒアリングシート（**No.2**）

**4**. 開業に至った経緯についてお聞かせください

現在、宮崎市熊野に家族とともに居住し、自治会活動や子どもの地域クラブ活動を通じて地域の方々と日常的に交流する中で、「近くに気軽に診てもらえる場所がない」という声を直接耳にする機会が多くありました。現職（早水公園クリニック副院長）での外来診療経験（通常150人/日・冬季250人/日）と外科・消化器外科の専門知識に加え、大学病院・防衛省・自衛隊での研究・教育・行政にわたる幅広い経験を総合して、宮崎市南部（木花・熊野地区）において地域に根ざした総合的なかかりつけ診療所を開業することを決意いたしました。同地区において、医療の質・利便性の両面から地域医療に貢献できると確信しております。

**5**. どのようなクリニックにしたいか　理念や経営方針をお聞かせください

理念：「気兼ねなく、何でも相談できる診療所でありたい。からだと暮らしの拠り所として、地域に根ざし続ける。」

経営方針：

【収益の柱】

保険診療を主軸とし、内科（生活習慣病・慢性疾患）・外科（処置・小手術）・消化器内科（上部内視鏡）の3本柱で1患者あたり単価5,000円を維持する。

自費診療（GLP-1（肥満症）・AGA/FAGA（脱毛症）・LOH症候群（男性更年期障害）、ED治療薬（勃起不全）・花粉症ケナコルト等）は保険診療と完全分離のうえ開業初日より展開し、月次収益の底上げを図る。

【患者数計画と損益管理】

開業初月25人/日から出発し、半年以内に損益分岐点（42人/日：据え置き期）到達、1年以内に月次黒字転換（52人/日）を目標とする。安定期（M18以降）は70人/日・月次余剰+108万円を見込む。加えて、開業初期の中休み・閑散時間帯にはイシャチョク®（仮想待合室型オンライン診療）を活用し、対面診療の合間に全国患者とのオンライン診療（単価4,000円/件・想定3〜5件/日）を行うことで月25〜44万円の補完収益を確保し、損益分岐点の実質的な引き下げ（対面換算▲4人/日）を図る。

【費用管理方針】

スタッフは開業時7名体制（看護師3・事務2・他2）でスタートし、患者数増加に応じて段階的に増員。高額機器（CT等）は損益分岐点到達後に追加調達し、開業初期の固定費を最小化する。

【差別化・集患戦略】

①外科専門医による処置・内視鏡の院内完結

②完全DX（Web予約・Web問診・自動精算）による受診利便性

③宮崎大学エリアの若年・中年層を狙った自費診療の展開

④医師会・地域病院との連携による紹介患者の取り込み

【院長報酬計画】

開業初期（M1〜6）月100万、成長期（M7〜12）月150万、安定期（M13〜）月220万と段階的に設定し、個人としての返済余力を確保しながら事業を拡大する。

**6**. 提供する医療提供体制（連携する病院、院内体制、ターゲット患者層等）についてお聞かせください

【連携病院・バックアップ体制】

・宮崎大学医学部附属病院（本学助教在職中のネットワークを活用）・宮崎県立宮崎病院（2022年10月から半年間手術参加し、つながりあり）、その他に南部病院へ紹介　ルートを確保予定

・代診医：松島俊介先生（医療法人社団聖山会 川南病院　救急科）

・土曜非常勤：松島医師による土曜午前対面診療を検討中

・宮崎市郡医師会 A会員として加入予定（牛谷義秀医師（うしたにクリニック理事長　宮崎市郡医師会副会長　防衛医科大学校同窓）に相談済）

【院内体制】

・院長（常勤）＋看護師3名（外来専従）＋医療事務2名＋フロアコンシェルジュ1名＋パート1名

・デジタルX線・経鼻内視鏡・超音波エコー・FeNO（喘息診断機）・心電図を開業初日より完備

・診療圏調査（成人35名＋小児16名＝51名/日ベース）に外科・CT需要を加算し、安定期70名/日を見込む

・標榜診療科目：内科・消化器内科・アレルギー内科・呼吸器内科・外科・小児科（6科）

・急性期病院と在宅医療の間をつなぐかかりつけ医として、①生活習慣病・慢性疾患の長期管理、②外科処置・小手術の一次対応、③消化器内科（胃カメラ）を開業初期か　ら提供します。Web予約・Web問診・自動精算・クラウド型電子カルテによるDX化を積極的に推進し患者の待ち時間を削減し、またフロアコンシェルジュが高齢者のデジ　タル操作を支援します。

・自費診療は保険診療と分離して適法に提供いたします。

【ターゲット患者層】

①子育て世代（学園台・まなび野エリア：乳幼児～小学生の小児科・感冒・喘息・胃腸炎・アレルギー）

②宮崎大学関係者・教職員（30～50代：生活習慣病・健診フォロー）／学生（感冒・喘息・胃腸炎・アレルギー）

③高齢者（熊野・清武エリア：慢性疾患管理・消化器・外科処置）

④就労世代（土日夕方外科処置外来の完全予約枠）

**7**. クリニックで強みとしたいことについてお聞かせください

①【外科専門医が担う、地域に不足する処置・検査の院内完結】

木花・熊野・清武エリアには、現在、外科専門医が常駐するクリニックがございません。外科・消化器外科専門医として、創傷処置・縫合・上部消化管内視鏡（胃カメラ）を院内で完結できる体制を整えることが、本クリニック最大の強みだと考えております。特に、週末の夜間に発生しやすいスポーツ外傷・切り傷などの救急外科処置にも対応できる体制を整え、地域住民が「軽い処置のためだけに遠方の救急病院へ行く」負担を少しでも解消したいと考えております。

②【宮崎大学立地を活かした、ITリテラシーの高い層への訴求】

本クリニックの立地は宮崎大学に近接しており、学生・教職員・研究者など、デジタルツールへの親和性が高い層が多く居住するエリアです。Web予約・Web問診・自動精算・キャッシュレス決済といった完全DX体制は、こうした層にとって親和性が高く、スムーズにご活用いただける環境です。一方で、デジタル操作に不慣れな患者様にはスタッフが丁寧にサポートする体制も併せて整えます。受診しやすさの面での差別化が、この立地における明確な強みだと考えております。

③【若年・中年層のニーズに応える自費診療の展開】

宮崎大学周辺という立地柄、AGA・禁煙支援・GLP-1（肥満予防）・男性LOH症候群/TRT（男性ホルモン補充療法）など、比較的若い世代のニーズに応える自費診療メニューを重点的に展開したいと考えております。大学病院や市中病院ではなく、身近なクリニックで気軽に相談・受診できる環境を整えることで、地域の若年・中年層の新たな受療行動を生み出せると考えております。

④【開業医としての長期的な地域貢献へのコミットメント】

外科・消化器外科専門医として十分な臨床経験・研究実績を積んだこの時期に開業することで、返済完了まで20年以上にわたり安定した医療を継続供給できる体制を整えております。地域に腰を据え、患者様・医師会・行政から長期にわたり信頼される「かかりつけ医」としての関係を着実に築いていくことが、本クリニックの根幹にある強みだと考えております。

⑤【イシャチョク®（仮想待合室型オンライン診療）による開業初期の患者数安定化】

開業初期や外来患者が少ない時間帯には、仮想待合室型オンライン診療プラットフォーム「イシャチョク®」を活用し、診療患者数の底上げを図る計画です。イシャチョク®は予約不要で全国の患者と医師をリアルタイムでマッチングするサービスであり、対面外来の合間の隙間時間に待機するだけで新規患者の保険診察が可能です。クリニックの知名度が十分に高まるまでの開業初期において、対面患者数の増減に左右されず一定の診療件数を確保できる仕組みを持つことは、資金繰りの安定という観点からも有効だと考えております。対面診療が優先であることは言うまでもなく、あくまで閑散時間帯の補完的な活用として位置づけております。

# お客さまヒアリングシート（**No.3**）

**7**. 予定クリニック情報

| | | | |
|---|---|---|---|
| クリニック名 | 木花のむら診療所 | | |
| 開業予定地 | 〒889-2162　宮崎県宮崎市熊野5233-2（接道交渉中） | | |
| 建物規模 | 木造2階建・延床面積約333㎡（1階272㎡・2階61.5㎡）・駐車場32台 | | |
| 開業予定時期 | 2027年秋（土地確定後12～15ヶ月） | 標榜診療科目 | 内科・消化器内科・アレルギー内科・呼吸器内科・外科・小児科 |
| 診療実施日 | 月～金 8:00～18:30（約205,850<br>,<br>000円（約2億585万円）実質診療8時間）<br>土　外科完全予約外来（院長単独・17:00～18:30）／将来的に土曜午前外来（8:00～12:00）予定<br>開院当初は日・祝　休診 | | |
| 想定外来患者数／日 | 開業初月：25人　→　安定期：70人 | 外来患者の疾患例 | 高血圧・糖尿病・脂質異常症・感染症・気管支喘息・花粉症・逆流性食道炎・外傷処置 |
| 想定手術件数／月<br>【手術をする場合】 | 外科小手術 月10～20件（皮膚腫瘤切除・陥入爪・巻き爪・創傷縫合等）<br>上部消化管内視鏡 月20～40件 | 手術対応の疾患例<br>【手術をする場合】 | 皮膚腫瘤切除・陥入爪・巻き爪・粉瘤・創傷縫合・上部消化管内視鏡検査（胃潰瘍・逆流性食道炎・早期胃癌スクリーニング） |
| 自由診療の有無 | 有（GLP-1・AGA・LOH・ED・花粉症ケナコルト等） | 薬局の内外 | 院外（門前薬局　AAO建築アトリエ経由で交渉中） |
| スタッフ構成 | 院長1名・看護師3名（常勤）・医療事務2名（常勤）・フロアコンシェルジュ1名・パートスタッフ1名　計8名 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 借入希望金額 | 約205,850,000円（約2億585万円） | 円 | 約205,850,000円（約2億585万円） |
| 借入希望期間 | 最長20年（土地・建物）／10年（機器・開業準備・運転資金） | 金利 | 固定金利を希望 |

**8**. その他　銀行に対し質問されたい事項

①【金利・融資条件について】

・20年固定金利の適用が可能か。また、現在の最優遇金利水準をお教えください。

・据え置き期間（1年間・利息のみ返済）の設定は可能でしょうか。

②【担保評価について】

・購入予定土地（熊野5233-2）の担保評価額の概算をお教えいただけますでしょうか。

・自宅不動産（熊野7465）を第二担保として設定する場合の評価方法をお教えいただけますでしょうか。

③【日本政策金融公庫との併用について】

・公庫の医療貸付（最大7,200万円）との協調融資は可能でしょうか。

・その場合の宮崎銀行様の融資額・条件はどのように変わりますでしょうか。

④【審査スケジュールについて】

・医療開業専門チームへの引き継ぎ後、審査完了までの標準的なスケジュールをお教えください。

・融資実行のタイミング（土地購入時・建設着工時・開業直前など）について、医療開業の実務上どのパターンが一般的か、また当方の状況に照らしてどのような方法が適切かをご

教示いただけますか。

【ご参考】現在、複数の金融機関にご相談を進めております。金利・融資条件・審査スケジュール・担保評価を総合的に比較したうえで、最終的なお願い先を決定させていただく予定でございます。宮崎銀行様には引き続きご支援いただければ幸いです。